

Geschäftsfallliste Kundenservice

Operative Guideline für Leistungsabrechnung, Deckungsfragen, Rechnungen und Vertragsanliegen

Verwendungszweck	Referenzdokument für Kundenservicemitarbeitende im telefonischen Tagesgeschäft einer Krankenkasse.
Arbeitslogik	Die Guideline bündelt fallübergreifende Standardprozesse und typische Geschäftsfälle. Sie dient der strukturierten Einordnung, der Informationssuche im System und als bewusst breites Nachschlagewerk.

Stand: März 2026

Inhaltsübersicht

1. Zweck und Anwendungslogik
2. Fallübergreifender Standardprozess
3. Produkteoffering, Leistungsgruppen, Leistungsverzeichnis
4. Einordnung von Vorfällen und Sofortmassnahmen
5. Pflichtangaben je Kanal
6. Dokumentationsstandard und Weiterleitung
7. Such- und Prüfmatrix im Gespräch
8. Typische Abgrenzungsfehler
9. Geschäftsfall Rechnung eingereicht, Leistung nicht gedeckt oder Produktfrage
10. Geschäftsfall Kostengutsprache oder vorgängige Genehmigung fehlt
11. Geschäftsfall Franchise, Selbstbehalt oder Eigenanteil unerwartet hoch
12. Geschäftsfall Doppelte Rechnungsstellung oder doppelte Leistungsverbuchung
13. Geschäftsfall Medikament oder Therapie abgelehnt wegen Limitierung
14. Geschäftsfall Unbekannte Rechnung einer Arztpraxis
15. Geschäftsfall Unfall oder Krankheit falsch zugeordnet
16. Geschäftsfall Behandlung im Ausland oder Notfall ausserhalb der Schweiz
17. Geschäftsfall Versicherungsbeginn, Unterbruch oder Deckungslücke unklar
18. Geschäftsfall Produktwechsel, Upgrade oder interne Deckungsabklärung
19. Geschäftsfall Hausarzt-, HMO- oder Telmed-Modell nicht eingehalten
20. Geschäftsfall Storno oder Gutschrift der Praxis bleibt ausstehend
21. Geschäftsfall Rückerstattung eingereicht, Auszahlung bleibt aus
22. Geschäftsfall Falsche Stammdaten, Bankverbindung oder Adresse mit Leistungsfolgen

1. Zweck und Anwendungslogik

Die Geschäftsfallliste dient als operative Referenz für typische telefonische Anfragen rund um Arztrechnungen, Deckungsfragen, Leistungsabrechnungen, Versicherungsmodelle, Produktwechsel und administrative Klärungen in der Krankenkasse. Sie bildet nicht nur einzelne Einzelfälle ab, sondern ein breiteres Set ähnlich gelagerter Fallogiken, damit Mitarbeitende im Gespräch relevante Informationen aktiv suchen und die Sachlage strukturiert einordnen.

Massgeblich sind Sachverhalt, Versicherungsdeckung, Tarif oder Rechnungsstatus, medizinischer Kontext, Zustimmungs- oder Genehmigungsstand, Vorabklarungen, Fristen, Nachweise und interne Zuständigkeiten.

Die Guideline ist deshalb so aufgebaut, dass zunächst die fallübergreifende Systematik festgelegt wird. Erst danach folgen konkrete Geschäftsfalltypen. Für alle Falltypen gilt: keine Zusagen über Vergütung oder Ablehnung ohne Datenbasis, keine vorschnelle Eskalation ohne Mindestangaben und keine Vermischung von Leistungsfragen mit Missbrauchs- oder Stammdatenfällen.

Wichtiger Hinweis: Die konkrete Fallzuordnung erfolgt immer anhand der Datenlage. Auch wenn ein Anruf auf den ersten Blick offensichtlich wirkt, muss zuerst geklärt werden, ob es sich um eine normale Kostenbeteiligung, eine fehlende Deckung, eine Bearbeitungsstufe, einen administrativen Fehler, einen Missbrauchsverdacht oder bloss eine noch nicht abgeschlossene Prüfung handelt.

2. Fallübergreifender Standardprozess

Standardablauf

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Identifikation	Zuerst immer die Identität des Kunden prüfen. Zwei von drei Datenpunkte müssen mindestens gesammelt werden: - Name und Vorname - Geburtsdatum - Wohnadresse
Anliegen strukturieren	Anliegen knapp spiegeln, Hauptproblem benennen, betroffene Leistung oder Rechnung erfassen und das erwartete Ergebnis klarziehen.
Berechtigung prüfen	Nur mit berechtigter Person sprechen. Identität nach Standard prüfen und dokumentieren, falls ein Eingriff, eine Abklärung oder Einsicht in sensible Falldaten erfolgt.
Leistung eingrenzen	Rechnung, Leistungsdatum, Leistungserbringer, Betrag, Diagnosebezug, Versicherungsprodukt, Modell und aktuellen Bearbeitungsstatus aufnehmen.
Falltyp bestimmen	Einordnen, ob es sich um eine Deckungsfrage, eine Kostenbeteiligung, einen Abrechnungsfehler, einen Missbrauchsverdacht, eine laufende Bearbeitung oder einen Vertragsfall handelt.

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Status und Fristen prüfen	Pendenzen, Freigaben, allfällige Fristen, Genehmigungsstatus und vorhandene Rückmeldungen im System prüfen, bevor eine Aussage über den weiteren Verlauf gemacht wird.
Sofortmassnahmen auslösen	Bei Missbrauch, falscher Stammdatenlage oder kritischem Leistungsstatus unverzüglich Prüfvermerk, Zahlungsstopp, Datenkorrektur oder interne Eskalation gemäss Prozess auslösen.
Nachweise definieren	Fehlende Unterlagen, Arztberichte, Verordnungen, Rechnungen, Zahlungsbelege, Policenhinweise oder Kontaktangaben konkret benennen.
Abschluss steuern	Nächste Schritte, Zuständigkeit, allfällige Wartezeiten und Dokumentation klar zusammenfassen.

3. Produkteoffering, Leistungsgruppen, Leistungsverzeichnis

Produkteoffering

Produkt	Charakter des Produkts	Enthaltene Leistungen	Nicht enthaltene Leistungen	Voraussetzungen für eine Prüfung oder Deckung
Basis	Grundlegender Versicherungsschutz mit Fokus auf regulären Standardleistungen	Standardleistungen, die eindeutig der regulären Grundversorgung zugeordnet werden können	Erweiterte ambulante Therapieformen, ergänzende Gesundheitsleistungen, präventive Zusatzleistungen und sonstige Leistungen ausserhalb des Standardumfangs	Es muss zunächst geprüft werden, ob die betreffende Leistung überhaupt dem regulären Standardumfang zugeordnet werden kann
Komfort	Erweiterter Versicherungsschutz mit zusätzlichen Leistungen für bestimmte ambulante und ergänzende Behandlungen	Alle Leistungen aus Basis sowie definierte zusätzliche ambulante Leistungen, sofern die jeweilige Leistung in der Komfortdeckung vorgesehen ist	Leistungen, die weder im Standardumfang noch in den ausdrücklich vorgesehenen Zusatzkategorien enthalten sind	Je nach Leistungsart können eine ärztliche Verordnung, eine fachliche Begründung oder weitere prüfbare Angaben erforderlich sein
Plus	Umfassenderer Versicherungsschutz mit erweitertem Leistungskatalog für ausgewählte Therapie- und Ergänzungsleistungen	Alle Leistungen aus Basis und Komfort sowie weitere definierte ergänzende oder therapeutische Leistungen, sofern die Bedingungen erfüllt sind	Leistungen, die auch im erweiterten Katalog nicht vorgesehen sind oder deren Voraussetzungen nicht erfüllt werden	Je nach Leistung können Verordnung, medizinische Indikation, prüfbare Unterlagen oder interne fachliche Beurteilung erforderlich sein

Leistungsgruppen

Leistungsgruppe	Beschreibung	Typische Einordnung	Mögliche Deckung nach Produkt	Bedeutung für die Bearbeitung
Standardmedizinische Pflichtleistung	Leistung, die klar dem regulären medizinischen Standardumfang zugeordnet werden kann	Reguläre ärztliche oder medizinisch notwendige Standardleistung innerhalb des üblichen Versorgungsspektrums	In der Regel in Basis, Komfort und Plus enthalten	Zuerst ist zu prüfen, ob die Rechnung, die Zuordnung und die Stammdaten plausibel sind. Wenn die Leistung korrekt zugeordnet ist, steht meist nicht die Produktfrage, sondern die sachliche Prüfung des Einzelfalls im Vordergrund
Erweiterte ambulante Therapie mit definierter Zusatzdeckung	Ambulante Leistung, die nicht mehr eindeutig zum Standardumfang gehört, aber in erweiterten Produkten vorgesehen sein kann	Zusätzliche Therapieform oder spezialisierte ambulante Leistung mit möglicher Deckung unter Bedingungen	In Basis in der Regel nicht enthalten, in Komfort oder Plus je nach Leistung und Voraussetzungen prüfbar	Hier muss immer unterschieden werden zwischen der Frage, ob die Leistung grundsätzlich im Produkt vorgesehen ist, und der Frage, ob die formalen oder medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind
Ergänzende oder präventive Leistung	Leistung mit ergänzendem, unterstützendem oder präventivem Charakter ausserhalb der engeren Standardversorgung	Gesundheitsfördernde, unterstützende oder ergänzende Behandlung mit möglicher Zusatzdeckung	In Basis nicht enthalten, in Komfort teilweise und in Plus eher möglich, jeweils nur bei vorgesehener Leistungskategorie	Bei solchen Leistungen ist besonders wichtig, ob das Produkt diese Leistungsart überhaupt kennt. Das Einreichen einer Rechnung allein genügt nicht für eine Deckung
Nicht vorgesehene Leistung	Leistung, die in keiner Produktlogik als regulär gedeckte Kategorie vorgesehen ist	Leistung ausserhalb der definierten Standard- und Zusatzkategorien	Weder in Basis noch in Komfort oder Plus regulär gedeckt	In solchen Fällen ist transparent zu kommunizieren, dass die Leistung nach aktueller Einordnung nicht gedeckt ist. Zulässig bleibt nur die Prüfung, ob allenfalls eine fehlerhafte oder unvollständige Einordnung vorliegt
Unklare oder bestrittene Rechnungsposition	Rechnung, deren Ursprung, Leistungserbringer, Leistungsbezug oder Plausibilität aus Sicht der versicherten Person nicht nachvollziehbar ist	Unbekannte Arztpraxis, nicht wiedererkennbare Behandlung, unplausible Rechnungsangaben oder bestrittene Leistung	Die Produktdeckung ist hier zunächst nachrangig. Zuerst steht die Prüfung der Rechnung, der Zuordnung und der Fallplausibilität im Vordergrund	In solchen Fällen ist zuerst abzuklären, ob überhaupt eine zutreffende Zuordnung vorliegt. Solange dies offen ist, darf die bloße Existenz einer Rechnung nicht mit einer bestätigten Leistungspflicht gleichgesetzt werden

Leistungsverzeichnis

Leistung	Leistungsgruppe	Basis	Komfort	Plus	Ärztliche Verordnung
Hausärztliche Konsultation	Standardmedizinische Pflichtleistung	Ja	Ja	Ja	In der Regel nicht erforderlich
Radiologische Standarddiagnostik	Standardmedizinische Pflichtleistung	Ja	Ja	Ja	Nur wenn die Untersuchung verordnungspflichtig ausgelöst wurde oder intern verlangt
Physiotherapie	Erweiterte ambulante Therapie mit definierter Zusatzdeckung	Nein	Ja, unter Voraussetzungen	Ja, unter Voraussetzungen	In der Regel ja
Ergotherapie	Erweiterte ambulante Therapie mit definierter Zusatzdeckung	Nein	Ja, unter Voraussetzungen	Ja, unter Voraussetzungen	Ja
Psychologische Kurztherapie im ambulanten Zusatzbereich	Erweiterte ambulante Therapie mit definierter Zusatzdeckung	Nein	Teilweise, unter Voraussetzungen	Ja, unter Voraussetzungen	Ja
Ernährungsberatung	Ergänzende oder präventive Leistung	Nein	Teilweise	Ja, unter Voraussetzungen	Fallabhängig
Präventive Rückenmassage	Ergänzende oder präventive Leistung	Nein	Nein oder nur in Ausnahmefällen	Teilweise, unter Voraussetzungen	In der Regel nein
Digitale Schlaf- oder Stressberatung	Ergänzende oder präventive Leistung	Nein	Teilweise	Ja, unter Voraussetzungen	In der Regel nein

4. Einordnung von Vorfällen und Sofortmassnahmen

Einordnung

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Deckungsfrage	Die versicherte Person möchte wissen, ob und in welchem Umfang eine Leistung von Grund- oder Zusatzversicherung übernommen wird. Schwerpunkt ist saubere Abgrenzung von Produkt, Modell und allfälligen Voraussetzungen.
Kostenbeteiligung	Eine Leistung ist grundsätzlich versichert, aber Franchise, Selbstbehalt, Spitalbeitrag oder andere Eigenanteile führen zu einer höheren Restbelastung. Schwerpunkt ist Erklärung der Kostenlogik.
Abrechnungs- oder Bearbeitungsfall	Die Leistung ist erfasst, aber Betrag, Status, Doppelverbuchung, fehlende Gutschrift oder ausstehende Auszahlung sind unklar. Schwerpunkt ist Statusprüfung vor Eskalation.

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Missbrauch oder Fehlzuordnung	Die versicherte Person bestreitet die Leistung oder weist auf klare Unstimmigkeiten hin. Schutzmassnahmen, Zahlungsstopp und Chronologie haben Vorrang vor Diskussionen über Deckung.
Vertrags- oder Modellfall	Produktwechsel, Versicherungsbeginn, Modellverletzung, Zusatzversicherung oder Stammdaten beeinflussen die Leistungsbeurteilung. Schwerpunkt ist saubere Prüfung von Gültigkeit und Regelwerk.

Wichtiger Hinweis: Sofortmassnahmen werden nur nach Fallogik ausgelöst. Bei Missbrauch oder falscher Stammdatenlage geht Schutz vor Detailerklärung. Bei Deckungs- und Kostenfallen geht saubere Einordnung vor Eskalation.

5. Pflichtangaben je Kanal

Mindestangaben

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Rechnung oder Leistungsabrechnung	Leistungserbringer, Leistungsdatum, Betrag, Tarif oder Leistungsbeschreibung, Status eingereicht oder verarbeitet, betroffene Police und vorhandene Belege.
Deckungsfrage vor Behandlung	Geplante Leistung, voraussichtlicher Zeitpunkt, behandelnde Stelle, medizinische Verordnung oder Empfehlung, betroffene Versicherung und bekannte Vorprüfungen.
Produkt- oder Modellanliegen	Aktuelles Produkt, gewünschtes Zielprodukt, Grund des Anrufs, relevante Fristen, Beginn oder Wechseltermin und bereits erfolgte Kontaktaufnahme.
Missbrauchsverdacht	Praxis oder Leistungserbringer, Datum, Betrag, bestrittene Leistung, Status der Rechnung, Plausibilitätsangaben und allfällige weitere verdächtige Vorgänge.
Rückerstattung oder Zahlung	Einreichdatum, Zahlungsweg, Bankverbindung, Fall- oder Leistungsnummer, Status im System und letzte Rückmeldung an die versicherte Person.
Stammdatenfall	Welche Daten betroffen sind, seit wann die Abweichung besteht, welche Leistung oder Auszahlung tangiert ist und ob weitere Systeme oder Dokumente betroffen sind.

6. Dokumentationsstandard und Weiterleitung

Dokumentationsfelder

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Anliegen	Kurz und sachlich beschreiben, welches Problem die versicherte Person meldet und welches Ergebnis sie erwartet.
Leistungsfall	Leistungserbringer, Datum, Betrag, Produkt, Modell, Bearbeitungsstatus, Rechnungskanal und relevante Systemhinweise.
Einordnung	Deckungsfrage, Kostenbeteiligung, Abrechnungsfehler, Missbrauchsverdacht, Vertragsfall oder laufende Bearbeitung.
Sofortmassnahmen	Prüfvermerk, Zahlungsstopp, Stammdatenkorrektur, interne Rückfrage, Hinweis auf weitere betroffene Rechnungen oder Police.
Offene Punkte	Welche Nachweise fehlen, welche Freigaben ausstehen und was vor einer formellen Weiterleitung noch benötigt wird.
Nächster Schritt	Wer macht was als Nächstes, über welchen Kanal und in welchem Zeitraum.

Interne Weiterleitungen sollen nur dann ausgelöst werden, wenn Mindestangaben und falltypische Voraussetzungen erfüllt sind. Unvollständige Weiterleitungen erzeugen Rückfragen, verzögern die Bearbeitung und führen zu doppelter Erklärungsarbeit.

Wo ein Formular, ein interner Briefkasten oder eine Fachabklärung vorgesehen ist, muss die Dokumentation so vollständig sein, dass eine zweite Stelle den Sachverhalt ohne erneute Grundaufklärung übernehmen kann.

7. Such- und Prüfmatrix im Gespräch

Empfohlene Suchreihenfolge

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Systemstatus	Zuerst Bearbeitungsstatus, Produkt, Modell und offene Fachprüfungen kontrollieren. Viele vermeintliche Fehler sind normale Bearbeitungsstufen oder ausstehende Belege.
Zeitlogik	Danach Leistungsdatum, Einreichdatum, Wechselzeitpunkte, Beginn der Deckung und letzte Systemereignisse verifizieren.
Beleglage	Vor Weiterleitung festhalten, welche Rechnungen, Verordnungen, Arztberichte, Stornierungen oder Zahlungsbelege vorhanden sind.
Plausibilität	Prüfen, ob Leistung, Diagnose, Ort, Produkt und Kundenprofil zusammenpassen oder ob Fehlzuordnung, Regelverstoss oder Missbrauch naheliegt.

Schritt	Erwartetes Vorgehen
Vertragslogik	Erst danach vertieft prüfen, welche Produktregeln, Modelleinschränkungen, Freigaben oder Fristen auf den Fall wirken.
Abschlusskontrolle	Zum Schluss sicherstellen, dass Aussage, Dokumentation und nächster Schritt zueinander passen.

8. Typische Abgrenzungsfehler

- Kostenbeteiligung mit fehlender Deckung verwechseln. Eine hohe Restbelastung bedeutet nicht automatisch, dass die Leistung unversichert war.
- Deckungsanfrage und Rechnungsstatus vermischen. Vor einer Produkt- oder Kulanzdiskussion zuerst prüfen, ob überhaupt schon definitiv entschieden wurde.
- Missbrauchsverdacht zu früh als bloße Verwechslung abbuchen. Wenn Praxis, Diagnose oder Ort nicht plausibel sind, Schutzmassnahmen einleiten.
- Produktwechsel als Sofortlösung darstellen. Ein neues Produkt kann künftige Fälle beeinflussen, aber nicht rückwirkend eine bereits ausgeschlossene Leistung decken, sofern keine besondere Regel greift.
- Modellverstoss und medizinische Notwendigkeit verwechseln. Auch medizinisch sinnvolle Leistungen können bei falschem Prozess anders bearbeitet werden.
- Ausstehende Gutschrift mit endgültiger Ablehnung verwechseln. Zwischen Bearbeitung, Fachprüfung und effektiver Entscheidung unterscheiden.

9. Geschäftsfall Rechnung eingereicht, Leistung nicht gedeckt oder Produktfrage

Zielbild des Falles: Es liegt eine eingereichte Rechnung oder Anfrage zu einer konkreten Behandlung vor. Die versicherte Person erwartet eine Übernahme, im aktuellen Produkt ist die Leistung jedoch nicht oder nicht eindeutig gedeckt.

Prüffragen

- Um welche Rechnung oder Behandlung geht es genau, mit welchem Betrag und welchem Leistungserbringer?
- Ist die Leistung bereits bearbeitet oder befindet sie sich noch in Prüfung?
- Welche Versicherung ist betroffen, nur Grundversicherung oder auch eine Zusatzversicherung?
- Weshalb erwartet die Person eine Übernahme und was wurde ihr bisher kommuniziert?
- Soll nur der aktuelle Fall geklärt werden oder will die Person auch künftige Deckungsoptionen verstehen?

Vorgehen

1. Anliegen sachlich strukturieren und die konkrete Rechnung, das Leistungsdatum und den Betrag aufnehmen.
2. Aktuellen Versicherungsumfang prüfen und klar zwischen heutiger Deckung und künftigen Produktoptionen unterscheiden.
3. Erläutern, weshalb die aktuelle Deckung die Leistung nicht oder nur teilweise umfasst, ohne vorschnelle Wertung oder Schuldzuweisung.
4. Falls prozesskonform, relevante Alternativprodukte oder Zusatzdeckungen für vergleichbare zukünftige Fälle aufzeigen.

5. Prüfen, ob innerhalb des aktuellen Produkts eine interne Fachrückfrage zu einer alternativen Leistungszuordnung sinnvoll ist, ohne eine Übernahme zu versprechen.
6. Den Unterschied zwischen Fallklärung jetzt und möglichem Produktwechsel für die Zukunft klar zusammenfassen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Rechnung oder Leistungsabrechnung mit Betrag und Datum
- Aktueller Produkt- oder Versicherungsstatus
- Gegebenenfalls Verordnung, Überweisung oder medizinische Begründung
- Hinweis, ob bereits eine frühere Auskunft oder interne Rückfrage besteht
- Wenn die Prüfung ergibt, dass die aktuelle Leistung im bestehenden Produkt nicht gedeckt ist, soll dies klar und verständlich ausgesprochen werden.
- Wenn fehlende Unterlagen den Deckungsentscheid voraussichtlich nicht verändern würden, soll dies sauber getrennt werden: Das Hauptthema ist dann nicht die Dokumentation, sondern die fehlende Deckung im aktuellen Produkt.
- Eine interne Fachrückfrage darf angeboten werden, wenn eine alternative Leistungszuordnung im aktuellen Produkt denkbar ist. Dabei darf jedoch keine Kostenübernahme in Aussicht gestellt werden.
- Produktalternativen, Zusatzdeckungen oder ein Produktwechsel dürfen nur als Lösung für zukünftige Fälle erläutert werden, nicht als rückwirkende Lösung für die bereits eingereichte Rechnung.
- Der Unterschied zwischen aktueller Fallklärung und künftiger Produktoptimierung ist am Ende des Gesprächs nochmals aktiv zusammenzufassen.

10. Geschäftsfall Kostengutsprache oder vorgängige Genehmigung fehlt

Zielbild des Falles: Eine Behandlung, Therapie, Rehabilitation oder ein Hilfsmittel setzt eine vorgängige Genehmigung oder Kostengutsprache voraus. Strittig ist, ob diese vorlag, noch eingeholt werden kann oder ob die versicherte Person im Vorfeld ungenügend informiert war.

Prüffragen

- Um welche geplante oder bereits durchgeführte Leistung geht es genau?
- Ist eine vorgängige Genehmigung laut Produkt oder Prozess erforderlich?
- Wurde bereits etwas eingereicht, bewilligt, abgelehnt oder nachgefordert?
- Gibt es eine Verordnung, einen Arztbericht oder einen Kostenvoranschlag?
- Geht es um die aktuelle Behandlung oder auch um die Fortsetzung weiterer Sitzungen?

Vorgehen

1. Leistung, Zeitpunkt und medizinischen Kontext genau erfassen.
2. Prüfen, ob laut Produkt oder internem Prozess eine vorgängige Genehmigung notwendig ist.
3. Status der Kostengutsprache im System kontrollieren und zwischen fehlender Einreichung, Pendeiz und Ablehnung unterscheiden.
4. Falls noch möglich, notwendige Unterlagen für die Fachprüfung benennen und den korrekten Einreichweg erklären.
5. Keine rückwirkende Zusage über Vergütung machen, solange Fachprüfung oder Regelwerk unklar sind.
6. Nächste Schritte und zuständige Fachstelle klar zusammenfassen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Verordnung oder medizinische Begründung
- Kostenvoranschlag oder Offerte

- Bisherige Korrespondenz zur Genehmigung
- Geplantes oder effektives Behandlungsdatum

11. Geschäftsfall Franchise, Selbstbehalt oder Eigenanteil unerwartet hoch

Zielbild des Falles: Die versicherte Person sieht eine Restbelastung und versteht nicht, weshalb trotz bestehender Versicherung ein hoher Anteil offenbleibt. Ziel ist die saubere Erklärung der Kostenlogik und die Trennung zwischen gedeckter Leistung und gesetzlicher oder vertraglicher Kostenbeteiligung.

Prüffragen

- Welche Abrechnung oder Rechnung löst die Nachfrage aus?
- Wie hoch sind Franchise, bereits geleistete Kosten und aktueller Eigenanteil?
- Ist die Leistung an sich anerkannt oder wurde sie teilweise abgelehnt?
- Gibt es Zusatzkomponenten wie Spitalbeitrag, nicht gedeckte Extras oder Medikamente ausserhalb der Liste?
- Braucht die Person primär eine Erklärung oder eine Prüfung auf Fehler in der Abrechnung?

Vorgehen

1. Abrechnung mit Datum, Betrag und Kostenkomponenten im System aufrufen.
2. Zwischen Franchise, Selbstbehalt, Spitalbeitrag, nicht gedeckten Leistungen und allfälligen Modellfolgen unterscheiden.
3. Nachvollziehbar erklären, welcher Teil der Rechnung grundsätzlich übernommen wurde und welcher Teil als Eigenanteil verbleibt.
4. Prüfen, ob auf der Abrechnung ein offensichtlicher Fehler, eine Doppelerfassung oder ein falscher Produktbezug sichtbar ist.
5. Keine Deckungsdiskussion aufmachen, wenn das Hauptproblem die normale Kostenbeteiligung ist.
6. Bei Bedarf auf künftige Planung, Produktvergleich oder interne Prüfung des konkreten Rechenwegs überleiten.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Betroffene Leistungsabrechnung
- Information zum Stand von Franchise und Selbstbehalt
- Rechnung oder Tarifdetail, falls einzelne Positionen bestritten werden
- Allfällige frühere Auskunft oder offene Einsprache

12. Geschäftsfall Doppelte Rechnungsstellung oder doppelte Leistungsverbuchung

Zielbild des Falles: Dieselbe Leistung scheint zweimal erfasst oder zweimal eingereicht worden zu sein. Entscheidungsrelevant sind Referenzen, Leistungsdaten, Leistungserbringer und der genaue Status beider Positionen.

Prüffragen

- Sind es wirklich zwei gleiche Leistungen oder nur ähnliche Positionen?
- Haben beide Positionen dasselbe Datum, denselben Betrag und denselben Leistungserbringer?
- Wurde eine Position storniert, korrigiert oder neu eingereicht?
- Ist bereits eine Auszahlung erfolgt oder befindet sich eine Position noch in Bearbeitung?
- Liegt die doppelte Sichtbarkeit allenfalls an Teilrechnungen oder an unterschiedlichen Verarbeitungsstufen?

Vorgehen

1. Beide Positionen mit Referenz, Datum, Betrag und Status exakt nebeneinander dokumentieren.
2. Prüfen, ob es sich um echte Doppelung, Korrekturbuchung, Teilrechnung oder zeitversetzte Bearbeitung handelt.
3. Falls eine unzulässige Doppelung vorliegt, den Fall gemäss Prozess an Fachstelle oder Rechnungsprüfung weiterleiten.
4. Keine vorschnelle Zusage über sofortige Auszahlung oder Belastungsrücknahme machen, solange der Status nicht geklärt ist.
5. Die versicherte Person über den Unterschied zwischen Sichtbarkeit im System und endgültiger Verarbeitung informieren.
6. Nächsten Schritt und voraussichtlichen Rückmeldekanal festhalten.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Beide Rechnungs- oder Leistungsreferenzen
- Rechnungsbelege oder Screenshots
- Information, ob bereits Zahlungen ausgelöst wurden
- Allfällige Störung oder Korrekturmeldung des Leistungserbringers

13. Geschäftsfall Medikament oder Therapie abgelehnt wegen Limitierung

Zielbild des Falles: Ein Medikament, eine Therapie oder ein Hilfsmittel wurde nicht oder nur teilweise übernommen. Im Mittelpunkt stehen Limitierungen, Listenstatus, Generikaregeln, Mengenbegrenzungen oder andere Leistungsvoraussetzungen.

Prüffragen

- Welche Leistung oder welches Medikament ist betroffen?
- Ist die Ablehnung definitiv oder handelt es sich um eine Nachforderung oder Pendeuz?
- Gibt es eine medizinische Verordnung oder Begründung?
- Beruht die Frage auf einer Listen- oder Limitierungsregel, auf einer Menge, auf einem Substitutionsentscheid oder auf fehlenden Unterlagen?
- Soll nur der aktuelle Fall erklärt oder auch nach einer deckungskonformen Alternative gesucht werden?

Vorgehen

1. Betroffene Position mit Produktbezug, Datum und Entscheidstatus aufnehmen.
2. Prüfen, welche Regel den Ausschlag gibt, etwa Listenstatus, Limitierung, Generikapflicht, Mengenobergrenze oder fehlende Begründung.
3. Der versicherten Person den Entscheid nachvollziehbar erklären, ohne medizinische oder fachliche Details zu erfinden.
4. Falls vorgesehen, auf mögliche nachreichbare Unterlagen oder deckungskonforme Alternativen hinweisen.
5. Keine verbindliche Aussage über Kulanz oder Ausnahmegewilligung ohne Fachprüfung machen.
6. Fachstelle oder nächsten Prüfschritt klar benennen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Rezept, Verordnung oder Arztbericht
- Ablehnungs- oder Pendeuzgrund aus dem System
- Rechnungs- oder Apothekenbeleg

- Allfällige Unterlagen zu medizinischer Notwendigkeit

14. Geschäftsfall Unbekannte Rechnung einer Arztpraxis

Zielbild des Falles: Es liegt eine Rechnungskopie oder eingereichte Leistung einer Praxis vor, bei der die versicherte Person nach eigener Aussage nie war. Der Fokus liegt auf Schutzmassnahmen, Plausibilitätsprüfung und sauberer Chronologie.

Prüffragen

- Welche Praxis, welches Leistungsdatum, welcher Betrag und welche Leistungsbeschreibung sind genannt?
- Ist die Rechnung erst eingereicht oder bereits verarbeitet beziehungsweise bezahlt?
- Kennt die versicherte Person die Praxis oder den medizinischen Sachverhalt?
- Passt die Praxis zum Wohnort, zum bisherigen Behandlungsverlauf oder zur bekannten Historie?
- Gibt es weitere auffällige Rechnungen oder andere Hinweise auf Verwechslung oder Missbrauch?

Vorgehen

1. Anliegen spiegeln, Identität prüfen und Rechnung mit Praxis, Datum, Betrag und Leistungsbeschreibung exakt aufnehmen.
2. Plausibilitätsfragen stellen, insbesondere ob die Praxis bekannt ist, der Ort plausibel ist und die beschriebene Leistung überhaupt zum Kunden passt.
3. Den Fall als bestrittene Rechnung oder Missbrauchsverdacht einordnen und unverzüglich Zahlungsstopp oder Prüfvermerk setzen, sofern prozesskonform.
4. Keine Spekulation über die Ursache. Neutral festhalten, ob Fehlzuordnung, Administrationsfehler oder Missbrauch in Betracht kommt.
5. Interne Abklärung mit der Praxis anstossen und gegebenenfalls weitere offene Rechnungen auf Auffälligkeiten prüfen.
6. Klar festhalten, dass bis zur Klärung keine Zahlungspflicht kommuniziert wird und die Krankenkasse die weitere Abklärung übernimmt.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Rechnungskopie oder Systemeintrag mit Praxis, Datum und Betrag
- Angaben zur unpassenden Diagnose oder Leistungsbeschreibung
- Allfällige weitere auffällige Rechnungen oder Meldungen
- Kontaktkanal für Rückmeldung nach Abschluss der Abklärung

15. Geschäftsfall Unfall oder Krankheit falsch zugeordnet

Zielbild des Falles: Die Rechnung oder Leistung wurde der falschen Kostenträgerschaft oder dem falschen Falltyp zugeordnet. Die Kernfrage ist, ob ein Unfall, eine Krankheit oder ein anderer Versicherungsweig zuständig ist.

Prüffragen

- Worum ging es medizinisch und wann ist das Ereignis eingetreten?
- Gibt es ein konkretes Unfallereignis oder entwickelte sich die Beschwerde ohne plötzliches äusseres Ereignis?
- Wurde der Fall bereits einem anderen Versicherer gemeldet?
- Ist die Ablehnung auf die Zustandsfrage oder auf fehlende Meldung zurückzuführen?

- Braucht es nur eine Einordnung oder eine Korrektur im System?

Vorgehen

1. Zeitpunkt und Kontext des gesundheitlichen Ereignisses aufnehmen.
2. Prüfen, wie der Fall im System klassifiziert ist und ob bereits eine Meldung oder Zustandsabklärung existiert.
3. Zwischen medizinischem Sachverhalt und administrativer Zustandsfrage trennen.
4. Wenn die Zuordnung unklar ist, keine definitive Zustandszusage geben, sondern Fachprüfung oder ergänzende Unterlagen anstossen.
5. Erläutern, welche Stelle für die nächste Klärung zuständig ist und welche Angaben noch benötigt werden.
6. Kundenverständliche Zusammenfassung geben, damit klar ist, warum die Zustandsfrage für die Kostenübernahme relevant ist.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Schilderung des Ereignisses und Datum
- Arztzeugnis oder Unfallmeldung, falls vorhanden
- Betroffene Rechnung oder Leistungsnummer
- Angaben zu bereits informierten Stellen oder Arbeitgeber

16. Geschäftsfall Behandlung im Ausland oder Notfall ausserhalb der Schweiz

Zielbild des Falles: Es wurde im Ausland eine Behandlung bezogen oder eine Notfallsituation trat ausserhalb der Schweiz auf. Zu klären sind Deckungsumfang, Notfallcharakter, Unterlagenlage und allfällige Abweichungen zwischen Grund- und Zusatzversicherung.

Prüffragen

- In welchem Land und in welchem Kontext fand die Behandlung statt?
- Handelte es sich um einen akuten Notfall oder um eine geplante Behandlung?
- Welche Rechnungen oder Belege liegen bereits vor?
- Besteht zusätzlicher Versicherungsschutz für Ausland oder Reise?
- Ist die Behandlung bereits bezahlt oder geht es um eine vorgängige Einschätzung?

Vorgehen

1. Land, Zeitpunkt, Leistungserbringer und Notfallkontext exakt aufnehmen.
2. Zwischen Notfall, geplanter Behandlung und reiner Beratungsanfrage unterscheiden.
3. Aktuellen Produktumfang prüfen und klar trennen, was aus Grundversicherung und was allenfalls aus Zusatzversicherung relevant sein könnte.
4. Unterlagenlage prüfen, insbesondere Originalrechnung, Zahlungsbeleg, medizinischer Bericht und allenfalls Übersetzung.
5. Keine pauschale Zusage über Vollübernahme im Ausland machen, solange Kontext und Produkt nicht sauber geprüft sind.
6. Nächste Schritte für Einreichung oder Fachprüfung transparent zusammenfassen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Originalrechnung und Zahlungsbeleg
- Medizinischer Bericht oder Austrittsunterlagen
- Angaben zum Reisezeitraum und Land
- Versicherungsprodukt mit Auslandskomponente

17. Geschäftsfall Versicherungsbeginn, Unterbruch oder Deckungslücke unklar

Zielbild des Falles: Die versicherte Person meldet eine Rechnung oder Behandlung, deren zeitlicher Bezug zum Versicherungsbeginn, zu einem Wechsel oder zu einer Unterbrechung unklar ist. Entscheidend sind Zeitlogik und Gültigkeit der Deckung.

Prüffragen

- Wann fand die Behandlung statt und seit wann besteht das aktuelle Versicherungsverhältnis?
- Gab es einen Wechsel, Austritt, Suspendierung oder eine verspätete Meldung?
- Bezieht sich die Frage auf Grundversicherung, Zusatzversicherung oder beides?
- Wurde die Person bereits über einen fehlenden Schutzzeitpunkt informiert?
- Gibt es nur eine Rechnung oder mehrere Leistungen im betroffenen Zeitraum?

Vorgehen

1. Leistungsdatum und Versicherungszeitraum nebeneinander prüfen.
2. Status im System kontrollieren, insbesondere Beginn, Ende, Wechseltermin oder allfällige Unterbrüche.
3. Zwischen echter Deckungslücke, verspäteter Erfassung und falscher Zuordnung unterscheiden.
4. Keine rückwirkende Deckungszusage machen, wenn der zeitliche Geltungsbereich ungeklärt ist.
5. Falls andere Versicherer, Vorversicherungen oder interne Vertragsstellen relevant sind, den korrekten Klärungspfad benennen.
6. Gesamtlogik des Falls in einfacher Sprache zusammenfassen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Police oder Vertragsdaten
- Rechnung mit Leistungsdatum
- Wechselbestätigung oder Korrespondenz zum Versicherungsbeginn
- Allfällige Vorversicherung oder Übertrittsangaben

18. Geschäftsfall Produktwechsel, Upgrade oder interne Deckungsabklärung

Zielbild des Falles: Die versicherte Person möchte aufgrund einer aktuellen Ablehnung oder einer erwarteten Behandlung ihr Produkt überdenken. Im Zentrum stehen Fristen, Zukunftsbezug und die saubere Trennung von Produktberatung und Fallentscheidung.

Prüffragen

- Welches aktuelle Produkt besteht und welches Zielprodukt interessiert die Person?
- Geht es um einen konkreten bereits eingetretenen Fall oder um künftige Deckung?
- Gibt es Fristen, Prüfungen oder Gesundheitsfragen für das Zielprodukt?
- Wurde bereits eine interne Fachrückfrage ausgelöst, ob der aktuelle Fall anders zugeordnet werden kann?
- Erwartet die Person eine sofortige Lösung für die bestehende Rechnung oder eine Orientierung für die Zukunft?

Vorgehen

1. Zuerst den aktuellen Fall sachlich abschliessen oder den Status der Fallprüfung erklären.
2. Danach separat darlegen, welche Produktoptionen für künftige Fälle relevant sein könnten.
3. Fristen, Form und allfällige Voraussetzungen eines Produktwechsels klar benennen.

4. Nicht den Eindruck erwecken, ein neuer Vertrag löse einen bereits eingetretenen Ausschluss automatisch.
5. Falls prozesskonform, interne Deckungsabklärung für den aktuellen Fall dokumentieren, ohne Ergebnis vorwegzunehmen.
6. Beratung und Fallbearbeitung sauber getrennt dokumentieren.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Aktueller Produktstatus
- Gewünschtes Zielprodukt oder Interessensbereich
- Betroffene Rechnung oder aktueller Leistungsfall
- Allfällige Hinweise zu Wechselterminen oder Gesundheitsprüfung

19. Geschäftsfall Hausarzt-, HMO- oder Telmed-Modell nicht eingehalten

Zielbild des Falles: Eine Leistung wurde unter einem eingeschränkten Modell bezogen, ohne den vorgegebenen Erstkontakt oder Prozess einzuhalten. Zu klären sind Modelllogik, Ausnahmen und die Auswirkungen auf die konkrete Leistung.

Prüffragen

- Welches Modell ist hinterlegt und welcher Ablauf war vorgesehen?
- Wie kam es zur Behandlung und bestand eine akute Notfallsituation?
- Wurde vorher doch jemand kontaktiert, etwa Telmed oder Hausarztpraxis?
- Ist die Rechnung bereits definitiv bearbeitet oder noch in Prüfung?
- Fragt die Person nach einer Erklärung, nach einer Ausnahme oder nach einem künftigen Modellwechsel?

Vorgehen

1. Modell und konkrete Behandlung im System aufrufen und den Fall zeitlich rekonstruieren.
2. Zwischen Notfall, zulässiger Ausnahme und klarem Modellverstoss unterscheiden.
3. Der versicherten Person erklären, weshalb der Prozess im Modell für die Leistung relevant ist.
4. Keine pauschale Zusage über nachträgliche Ausnahme machen, solange diese nicht fachlich geprüft wurde.
5. Falls sinnvoll, auf künftige Verhaltensregeln oder geeignetere Modelle hinweisen.
6. Konkreten Status der betroffenen Rechnung und den nächsten Schritt dokumentieren.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Aktuelles Modell und Versicherungsprodukt
- Rechnung oder Behandlungsnachweis
- Allfällige Kontaktprotokolle zu Telmed oder Hausarzt
- Hinweis auf Notfall oder akute Ausnahmesituation

20. Geschäftsfall Storno oder Gutschrift der Praxis bleibt ausstehend

Zielbild des Falles: Eine Praxis, Apotheke oder ein anderer Leistungserbringer hat eine Korrektur, ein Storno oder eine Gutschrift in Aussicht gestellt, im System ist diese aber noch nicht sichtbar. Schwerpunkt ist Fristprüfung und klare Abgrenzung zwischen zugesagter Korrektur und bereits verarbeiteter Gutschrift.

Prüffragen

- Welche ursprüngliche Rechnung ist betroffen und welche Korrektur wurde zugesagt?

- Liegt eine Bestätigung des Leistungserbringers vor?
- Ist im System bereits eine Gegenbuchung, Pendenz oder neue Rechnung sichtbar?
- Wie lange ist die zugesagte Korrektur bereits her?
- Gibt es durch die ausstehende Gutschrift eine konkrete Belastung oder Mahnung?

Vorgehen

1. Ursprungsrechnung, zugesagte Korrektur und Zeitachse exakt dokumentieren.
2. Prüfen, ob eine Gutschrift in Bearbeitung, bereits verbucht oder überhaupt noch nicht eingegangen ist.
3. Erläutern, dass Zusage des Leistungserbringers und sichtbare Verarbeitung im System nicht dasselbe sind.
4. Falls die übliche Wartefrist abgelaufen ist, fachliche Nachverfolgung oder Rückfrage anstossen.
5. Keine sofortige Korrektur versprechen, solange die Gegenbuchung nicht verifiziert ist.
6. Nächsten Prüfschritt und allfällige Zwischeninformation festhalten.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Korrespondenz oder Bestätigung des Leistungserbringers
- Ursprungsrechnung und allfällige neue Referenz
- Zeitpunkt der zugesagten Korrektur
- Information zu Mahnung oder offener Belastung

21. Geschäftsfall Rückerstattung eingereicht, Auszahlung bleibt aus

Zielbild des Falles: Eine Rechnung oder ein Leistungsdossier wurde eingereicht, die versicherte Person sieht aber noch keine Auszahlung. Entscheidend sind Einreichweg, Status, Pendenzen und Bankverbindung.

Prüffragen

- Wann und über welchen Kanal wurde die Rechnung eingereicht?
- Ist die Rechnung vollständig oder wurden Unterlagen nachgefordert?
- Liegt bereits ein Entscheid oder nur eine Eingangsbestätigung vor?
- Stimmt die hinterlegte Bankverbindung und die Adresse noch?
- Gibt es mehrere ausstehende Einreichungen oder nur einen Fall?

Vorgehen

1. Einreichdatum, Kanal und betroffene Referenz aufnehmen.
2. Im System prüfen, ob die Unterlagen eingegangen, pendent, in Fachprüfung oder bereits zur Auszahlung freigegeben sind.
3. Zwischen normaler Bearbeitungszeit, fehlenden Unterlagen und technischer Auszahlungssperre unterscheiden.
4. Stammdaten wie Bankverbindung und Adresse mitprüfen, wenn eine Auszahlung aussteht.
5. Keine Zusage über ein exaktes Auszahlungsdatum machen, solange Bearbeitung oder Freigabe nicht gesichert ist.
6. Den konkret nächsten Schritt nennen, etwa Unterlagen nachreichen, Wartefrist abwarten oder Fachstelle einschalten.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Einreichbestätigung oder Referenznummer
- Rechnung und allfällige Nachforderungen
- Aktuelle Bankverbindung
- Zeitpunkt der letzten Kundenrückmeldung

22. Geschäftsfall Falsche Stammdaten, Bankverbindung oder Adresse mit Leistungsfolgen

Zielbild des Falles: Falsche oder veraltete Stammdaten führen dazu, dass Rechnungen, Leistungsabrechnungen oder Auszahlungen nicht korrekt zugeordnet oder zugestellt werden. Schutz der Daten und saubere Korrektur stehen im Vordergrund.

Prüffragen

- Welche Stammdaten sind falsch oder veraltet?
- Seit wann besteht die Abweichung und welche Leistung oder Auszahlung ist konkret betroffen?
- Gab es bereits eine Änderungsmeldung oder mehrere betroffene Dokumente?
- Ist nur die Zustellung betroffen oder auch die Auszahlung?
- Gibt es Hinweise auf unberechtigte Änderungen oder bloss auf einen administrativen Fehler?

Vorgehen

1. Identität besonders sauber prüfen, bevor Stammdaten besprochen oder geändert werden.
2. Betroffene Daten, Zeitpunkt und Auswirkungen auf Leistung, Rechnung oder Auszahlung systematisch aufnehmen.
3. Zwischen normaler Korrektur und möglichem Missbrauch unterscheiden und bei Verdacht zusätzliche Sicherungsmassnahmen auslösen.
4. Prüfen, welche offenen Falle, Zahlungen oder Dokumente durch die falschen Daten tangiert sind.
5. Keine verbindliche Aussage über bereits ausgelöste Zahlungen oder Schreiben machen, ohne Systemstatus zu prüfen.
6. Korrekturpfad, Folgewirkung und nächsten Schritt für die versicherte Person klar zusammenfassen.

Benötigte Nachweise oder Vorabklärungen

- Neue und bisherige Stammdaten
- Betroffene Leistungs- oder Zahlungsreferenzen
- Zeitpunkt einer allfälligen Änderungsmeldung